# 08. EL CORAZÓN : DINÁMICA DEL MOVIMIENTO DEL DESARROLLO

DURACIÓN : 11:04 FICHA PEDAGÓGICA


## RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en la embriología cardíaca, explorando las etapas fundamentales del crecimiento del corazón al inicio del desarrollo embrionario. Se abordan conceptos clave como el acercamiento de los tubos endocárdicos, el movimiento en 'looping' y los procesos de inversión que transforman el corazón. El formador subraya la importancia de comprender la dinámica entre el corazón y el hígado, así como la necesidad de seguir la huella embrionaria para acompañar mejor a los pacientes. Al integrar estos conocimientos, los profesionales podrán afinar su enfoque biodinámico, favoreciendo así un desarrollo armonioso en sus pacientes.


## EL CORAZÓN: DINÁMICA DEL MOVIMIENTO DEL DESARROLLO

### INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO CARDÍACO EMBRIONARIO

Vamos a observar el **crecimiento exponencial** y el **enrollamiento** del embrión.

Aquí, vemos únicamente la **cavidad vitelina**. Arriba, la **cavidad amniótica** ha sido cortada.

Hay un **crecimiento longitudinal** y una **flexión**. Se distinguen el **sistema nervioso**, los **somitas** y los **sistemas vasculares**.

Prestemos atención a un orificio, el **futuro orificio del celoma intraembrionario**. Hay que imaginarlo aquí. Más tarde, transformará este celoma externo en un celoma interno.

El impresionante crecimiento del sistema acerca los dos **tubos endocárdicos primitivos** a la línea media, debido a una **velocidad de crecimiento diferencial**, influenciada por la **notocorda**.

Este acercamiento de los tubos endocárdicos forma, arriba, el **intestino**, y alrededor, la **cavidad intraembrionaria**. En esta etapa, formará la **cavidad pericárdica**, y no la cavidad peritoneal.

La **vesícula vitelina** se acerca para formar la parte superior del intestino.

## MOVIMIENTOS CLAVE DEL DESARROLLO CARDÍACO

El acercamiento de los dos tubos endocárdicos forma la zona del **tubo cardíaco** en desarrollo.

Se observa un movimiento de acercamiento hacia la línea media y, simultáneamente, un movimiento donde el cerebro "hace esto". Es una combinación de ambos.

Este proceso es sincrónico con la fase de **flexión** del embrión. El encuentro de los pulgares simboliza este primer movimiento a nivel del corazón.

### EL MOVIMIENTO EN "LOOPING" DEL CORAZÓN

El corazón, en vista sagital, se encuentra y busca desarrollarse. Le falta espacio detrás de él, y poco espacio a la izquierda o a la derecha. Solo tiene espacio hacia adelante.

Dentro del propio corazón, encontrará su propio **fulcro**. Al estar la parte posterior bloqueada, se desarrolla hacia adelante, realizando lo que se conoce como el **movimiento en "looping"** del corazón. Esta es la fase 2.

Este desarrollo continuo forma un tercer nivel. El espacio entre el **sistema ventricular** y la **aurícula** se convierte en un punto de apoyo. El ventrículo, inicialmente arriba, se encuentra abajo en relación con el sistema. Es un movimiento de **inversión**.

Aquí están los tres movimientos principales:

1. **Acercamiento** hacia la línea media y el encuentro.

2. **Movimiento en "looping"** hacia adelante.

3. **Proceso de inversión** del ventrículo.

### LA INFLUENCIA DE LA CAVIDAD PERITONEAL Y LA RUPTURA DE SIMETRÍA

El tercer movimiento está relacionado con el proceso de inversión, que es un proceso de desarrollo de la **cavidad peritoneal**.

El desarrollo del **hígado** provoca un cambio en el movimiento. La cavidad posterior de los epiplones desplaza el bronquio subizquierdo más arriba en relación con el derecho, relacionado con la **ruptura de la simetría axial**.

Por lo tanto, se observa un movimiento de desarrollo hacia adelante, pero también hacia la izquierda. Es un **doble basculamiento**.

Retengamos principalmente:

- El **acercamiento** del corazón hacia la línea media.
- El **desarrollo** hacia adelante.
- Un desarrollo simultáneo hacia la izquierda.

El **sistema sinusoide** del hígado se posicionará hacia arriba después de este basculamiento.

### ORGANIZACIÓN DE LOS GRANDES VASOS

El primer movimiento, luego el segundo movimiento relacionado con el basculamiento, y finalmente un tercer movimiento que organiza los **grandes vasos** arriba.

El corazón está basculado, mantenido por un eje, y equilibrado en relación con el **plano vascular**. Hay un desarrollo más importante de un lado.

Es un equilibrio entre la parte **torácica**, la parte **abdominal** y la parte **visceral baja**. Un movimiento muy importante se sitúa entre el corazón, el estómago y el hígado.

## LA HUELLA EMBRIONARIA EN EL ENFOQUE BIODINÁMICO

Un punto de referencia muy importante a reequilibrar es el **movimiento hepático**. Se observa si el hígado está bien en su movimiento de desarrollo o si está en retroceso.

Si el hígado se detiene, hay una pequeña parada.

A nivel del corazón, su desarrollo hará lo contrario. Hay una trayectoria, como una **huella**.

Hay que posicionarse en la huella embrionaria, ir donde el sistema desea ir, ahí es donde está el **punto de silencio**.

Si el movimiento no va lo suficientemente lejos, hay que ayudar al sistema. Esta organización del corazón está fuertemente influenciada por el hígado. De ahí la importancia de comprender el papel del hígado.

En la embriología biodinámica, no se impone. No se rechazan ni los **codos fasciales**, ni el lado **fluido**, ni las técnicas **estructurales**, **viscerales** u otras.

El enfoque es adaptarse a lo que se siente en el momento presente. La fuerza terapéutica reside en el encuentro de los dos neutros.

Los procesos de regeneración en **osteopatía biodinámica** utilizan estos movimientos embrionarios. No se trata de terapia directa, sino de reconocer los movimientos de desarrollo embrionarios que aparecen en los procesos terapéuticos guiados por la **"marea"**.

Es crucial reconocer la frecuencia en la que uno se encuentra.

## LA ENERGÍA DEL CORAZÓN Y SU ENTORNO

Rara vez se toca el corazón directamente al principio. El corazón se forma por el **eco** de la periferia.

El corazón es extremadamente potente porque recibe una información muy importante de la **"neural crest"** (cresta neural). Recibe una información eléctrica aún más potente a nivel neurológico.

Esto significa que se puede aprender a sentir el corazón a distancia, o que el corazón se siente a distancia. Tiene una potencia, una **radiación**. Las mediciones han mostrado una radiación de hasta 5 metros mínimo de la persona, probablemente relacionada con la cresta neural.

Es a nivel **venoso** donde habrá un desarrollo, llamado el **seno venoso** del corazón. En este seno venoso se reunirán las **venas cardinales**, las **venas umbilicales** y las **venas vitelinas**, sufriendo numerosas remodelaciones.

El corazón posee un entorno **fascial** y su propia **electricidad** para su latido. Sin embargo, esta electricidad no era suficiente para mantener el corazón en su justa función. Depende fuertemente de todo su entorno fascial.

Los **ligamentos esterno-pericárdico**, **frénico-pericárdico**, **vértebro-pericárdico**, y la **aorta superior**, suspendidos hasta el tubérculo faríngeo, sostienen la **ritmicidad** del corazón.

El sistema de anclaje del corazón es un sistema de **oscilación cerrado**. Su estructura tisular y molecular está diseñada para sufrir un movimiento de estiramiento en cada latido. Es como un sistema de **elásticos** que devuelven constantemente el corazón a su posición de equilibrio.

Esta estructuración de la **fascia tisular** del pericardio sostiene el corazón, y el corazón mismo es sostenido en su ritmicidad por su entorno fascial.

Todo el sistema fascial alrededor del corazón puede influir en su ritmo. De ahí la importancia de la **libertad estructural** del entorno cardíaco. Es ahí donde una acción directa es posible.

El corazón en **sístole-diástole** debe ser visto como un **pulpo** ("octopus"), con el **cayado aórtico** y todo el tronco descendente hasta las uniones.

No es solo el cuerpo, sino también sus "tentáculos" los que pueden sentirse. En el vientre, en la garganta, en los pies, en los dedos.

Esto implica que una **desestabilización** de la cadera puede desestabilizar el corazón. Existen casos de **arritmias** que pueden mejorar liberando las caderas.

Existe una relación compleja a través del **endotelio**, este tejido que conecta todo el sistema.

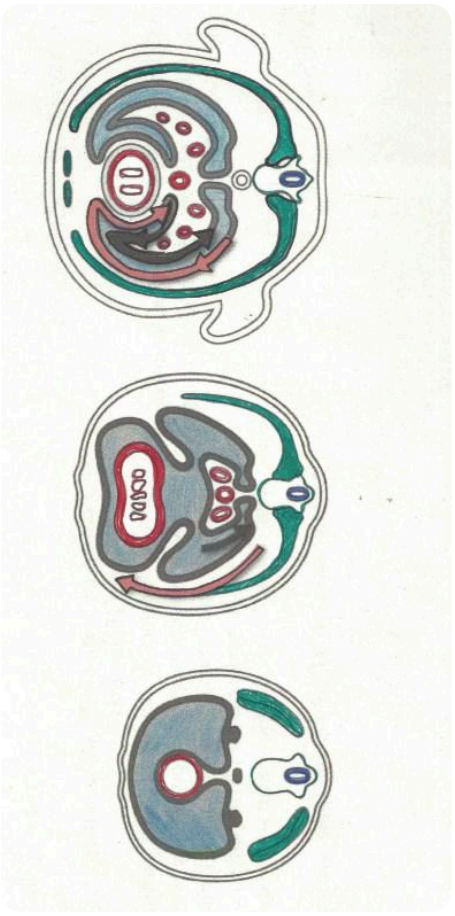


*FIG. — Plegamiento embrionario lateral*

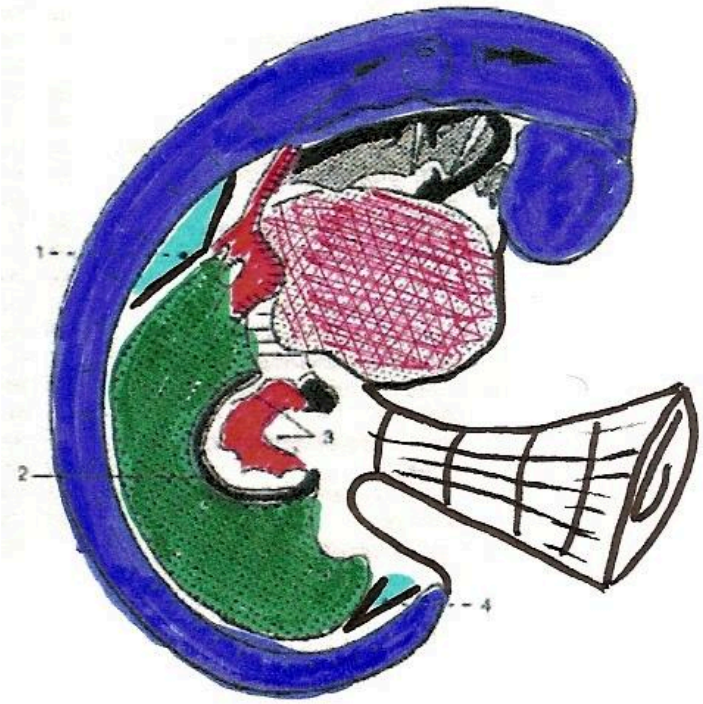



*FIG. — Embrión con alantoides*

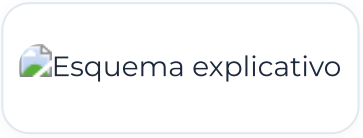



*FIG. — Esquema explicativo*

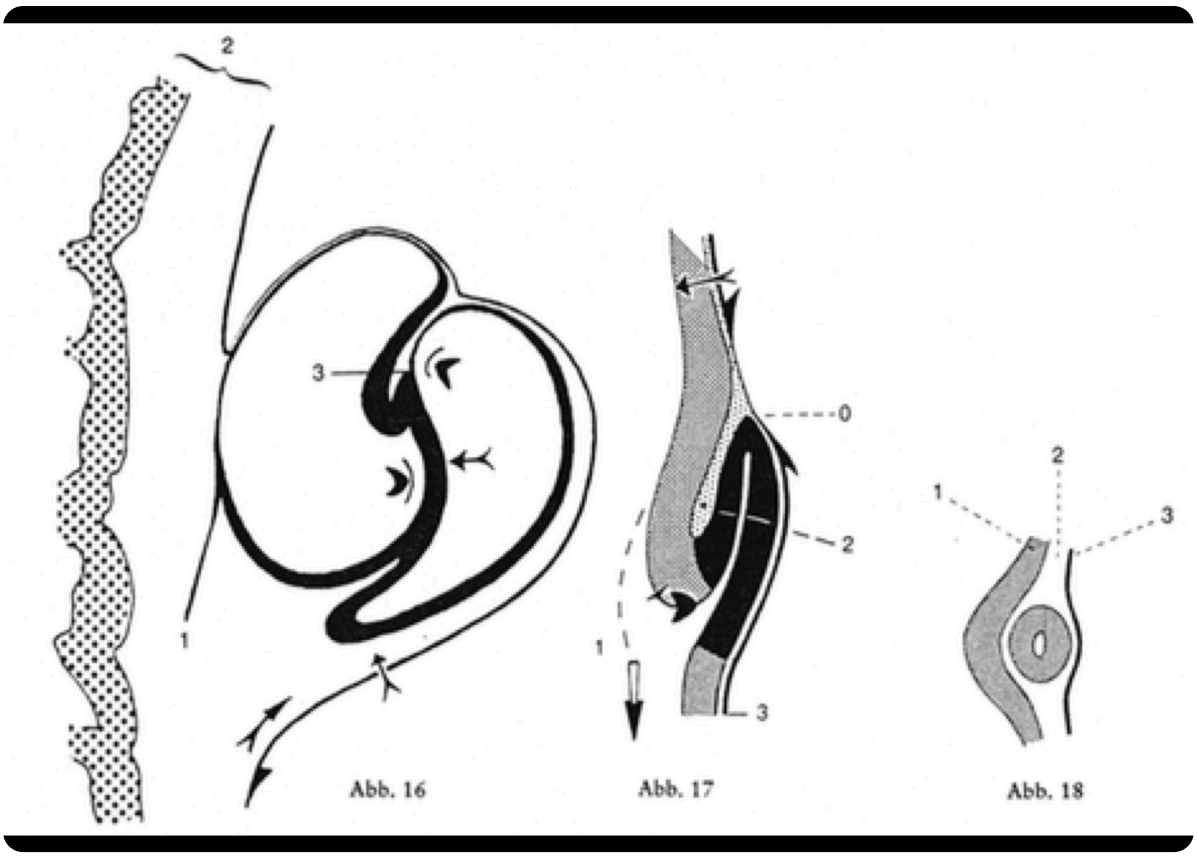



*FIG. — Desarrollo del tubo neural*

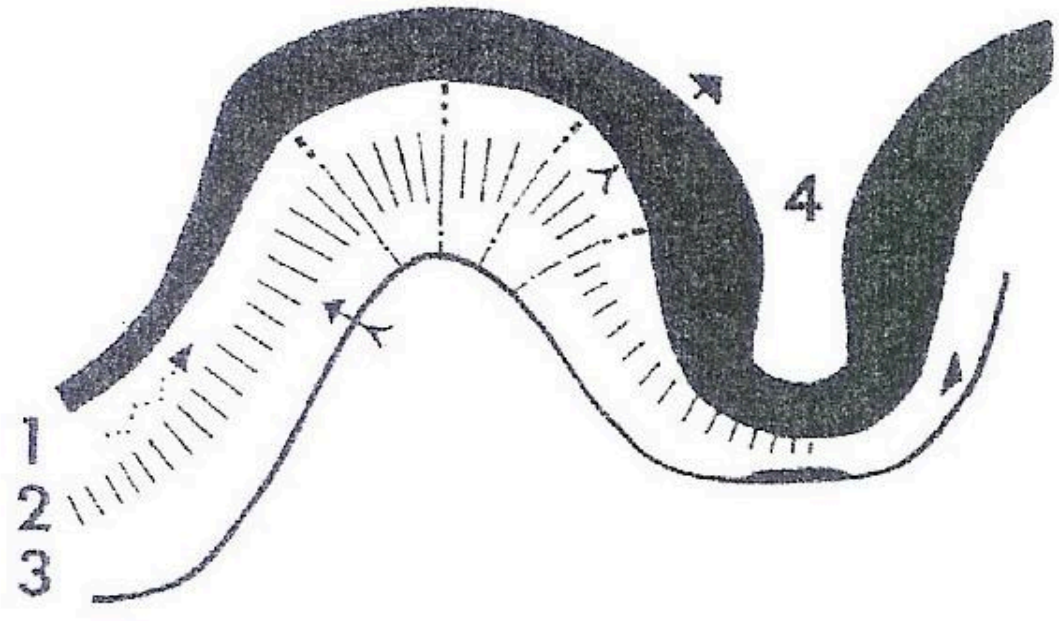



*FIG. — Placa neural, surco*

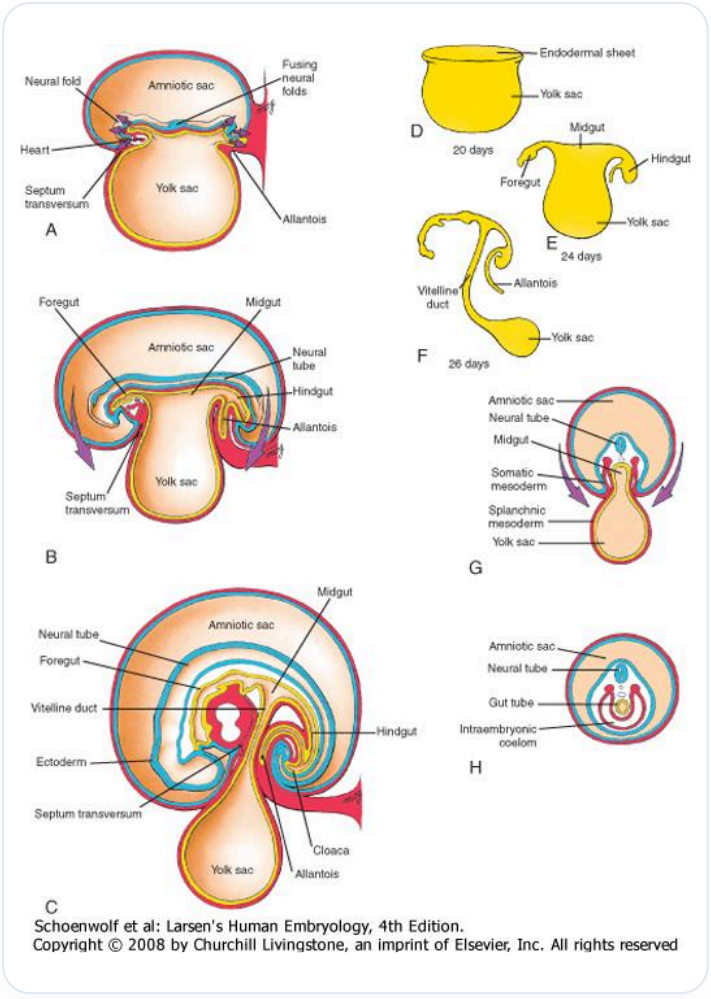



*FIG. — Desarrollo del tubo digestivo embrionario*

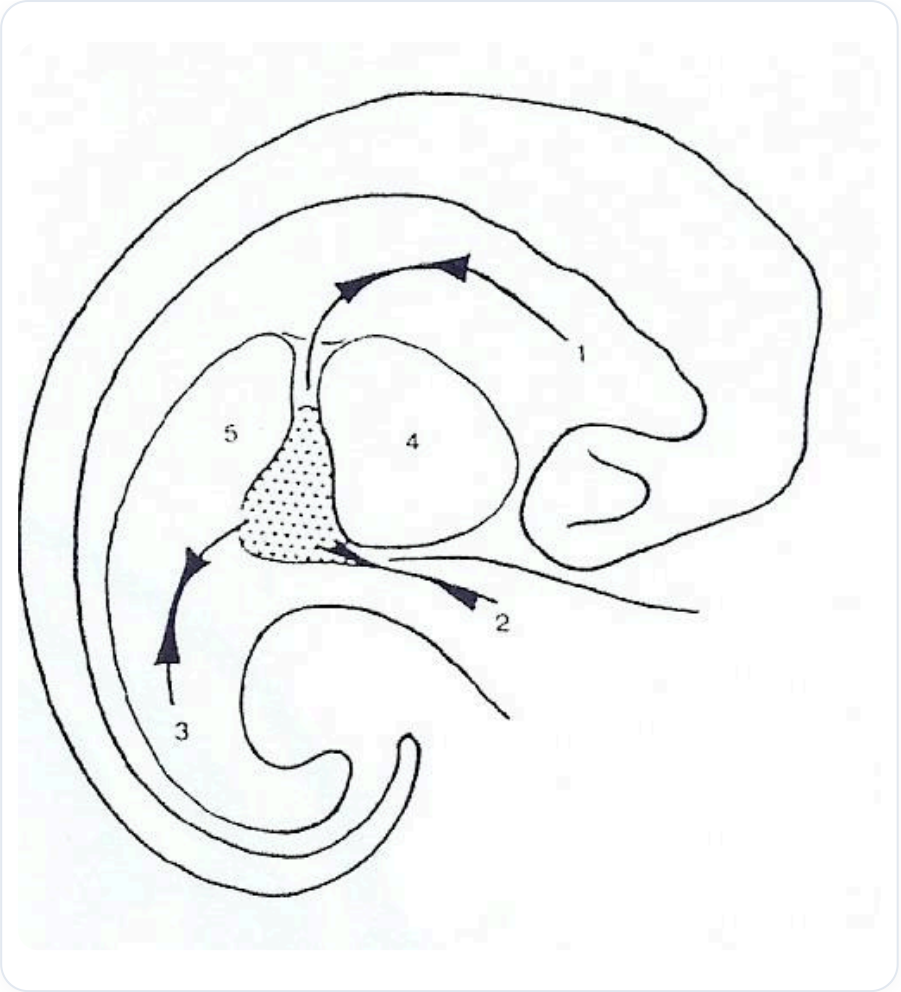



*FIG. — Circulation embryo liquide céphalo-rachidien*